UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO

CARRERA DE MEDICINA

SÍNDROME DE BURNOUT ASOCIADO AL ESTRÉS LABORAL EN INTERNOS DE MEDICINA DE 25 A 45 AÑOS EN EL HOSPITAL BOLIVIANO HOLANDES Y HOSPITAL LOS PINOS, FEBRERO-JUNIO, 2026

DOCENTE A CARGO: Dra. Miriam Doritza Bautista Callisaya

INTEGRANTES:

- **Caceres Ccoarite Leidy Nikol**
- **Calla Ayma Cinthia Elizabeth**
- **Escobedo Estofanero Jhadde Vanessa**
- **Marquez Divapuri Lucia Nataly**
- **Panca Apaza Rosaura**
- **Quispe Castro Sheyla Mayly**
- **Rodriguez Cordova Albert Pablo**
- **Sucapuca Apaza Mary Cielo**
- **Ticona Quispe Ana Yulissa**

LA PAZ BOLIVIA

2026

RESUMEN

El síndrome de Burnout (SB) es un problema de salud mental cada vez más urgente en entornos académicos y hospitalarios, especialmente en profesiones exigentes como la medicina. Se caracteriza por tres aspectos principales: agotamiento emocional, despersonalización y bajo rendimiento personal, que no sólo afectan la salud del individuo sino también el rendimiento académico y la calidad de la atención médica brindada a los pacientes. En el contexto boliviano, numerosos estudios e informes institucionales muestran un aumento paulatino de los problemas relacionados con el estrés, la ansiedad y la fatiga en estudiantes y personal médico, especialmente durante las fases de formación clínica como las rotaciones clínicas. Factores como largas jornadas laborales, presión académica, falta de tiempo de descanso adecuado e instalaciones hospitalarias contribuyen significativamente al desarrollo del síndrome, convirtiéndolo en un nuevo problema epidemiológico de importancia en el país. El objetivo de este estudio fue analizar la relación entre burnout y estrés laboral en médicos internos de 25 a 45 años de los hospitales Boliviano Holandes y Los Pinos entre febrero y junio de 2026, teniendo en cuenta variables como la calidad del sueño, la carga de trabajo y factores psicosociales relacionados.

Debido a que la investigación se encuentra en fase de implementación, los resultados finales aún no están disponibles; Sin embargo, se espera demostrar una relación significativa entre los altos niveles de estrés percibido y la aparición de burnout, así como identificar determinantes que nos permitan comprender mejor su impacto en esta población. También se espera que estos hallazgos contribuyan al desarrollo de estrategias de prevención e intervención para mejorar la salud mental, el rendimiento académico y la calidad de vida de los trabajadores de la salud en el futuro.

1.INTRODUCCIÓN

El síndrome de burnout se define como una manera poco apropiada de enfrentar un estrés emocional crónico frente al trabajo, caracterizado por cansancio emocional,

despersonalización y baja realización personal, aunque se ha añadido un cuarto componente en el contexto estudiantil, conocido como negative learning emotion (emoción negativa frente al aprendizaje). En los alumnos de pregrado el rigor académico y otros factores de tensión a los que se ven sometidos pueden provocar síndrome de burnout, trastorno que, a su vez, produce bajo sentido de pertenencia con la institución, bajo rendimiento académico, consecuencias negativas en la atención al paciente e incluso intentos de suicidio. Por ello, las instituciones de educación superior, cuya premisa es ofrecer una enseñanza de calidad, requieren ejecutar programas para notificar y manejar el síndrome de burnout entre su cuerpo estudiantil. Igual que ocurre con los profesionales formales, los alumnos universitarios pueden enfrentar contextos donde padecen riesgos y perjuicios psicosociales ante estresores y demandas habituales colosales o inapropiadas, crónicamente no resueltas o de manera poco apropiada, que dependen de los entornos organizacionales de educación superior, de la labor académica de los alumnos y de componentes psicológicos individuales no propicios. Ante esta situación, los estudiantes pueden ofrecer respuestas no adaptativas y dañinas como el denominado síndrome de quemarse por los estudios (burnout académico), con las consecuentes secuelas negativas para su salud psicosocial o bienestar psicológico, para su papel y trayectoria académica, insatisfacción con los estudios y, en consecuencia, el abandono escolar. De la misma manera, este síndrome provoca alteraciones en los sistemas fisiológicos (en el sistema inmunitario y en el sistema nervioso autónomo) como disfunciones psicofisiológicas manifestadas por cefalea, complicaciones cardiovasculares, digestivas y sexuales. Asimismo, puede provocar una inmunodepresión que incrementa el riesgo de infecciones como la gripe y desarrolla la probabilidad de enfermedades inmunológicas. Además, los cambios cognitivos propician un conjunto de sesgos o dificultades en la interpretación de la conducta, la activación fisiológica y el pensamiento, que provocan la adquisición de un conjunto de dudas irracionales y alteraciones de tipo emocional. (1)

Estudios realizados internacionalmente tal como este: “Prevalencia del síndrome de burnout en médicos que trabajan en España: revisión sistemática y metaanálisis”,

realizado por los doctores Antonio Pujol-de Castro, Grecia Valerio-Rao, Pablo Vaquero-Cepeda y Ferrán Catalá-López, y publicado en 2024 en la revista científica Revista Clínica Española. Este trabajo tuvo como objetivo estimar la prevalencia del síndrome de burnout entre los médicos en España, evaluando las tres dimensiones del síndrome: agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal, se analizaron 67 estudios de un total de 1,616 artículos, incluyendo a 16,076 médicos españoles, utilizando principalmente el Maslach Burnout Inventory (MBI), se encontró que la prevalencia del síndrome de burnout completo fue del 24%, pero aumentó al 51% cuando se consideró al menos una dimensión afectada, la dimensión más frecuente fue el agotamiento emocional (40%), seguida de la despersonalización (30%) y la baja realización personal (27%) (2).

En Bolivia, las investigaciones sobre el síndrome de Burnout en población universitaria aún son escasas; sin embargo, algunos estudios recientes permiten evidenciar la presencia y relevancia de este fenómeno en el contexto académico nacional.

Un estudio realizado por Salinas Nina (2023), titulado “Prevalencia y distribución del síndrome de Burnout Student en estudiantes de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés”, identificó una prevalencia del 14,4 % del síndrome en esta población, siendo la dimensión de agotamiento emocional la más afectada, con un 54,4 % de los casos. Aunque el estudio no abordó directamente los trastornos del sueño, sus resultados reflejan el impacto del estrés académico y la carga emocional en los estudiantes de educación superior en Bolivia, evidenciando la necesidad de investigar los factores asociados al bienestar mental en este grupo (3).

2.JUSTIFICACIÓN

El síndrome de Burnout y sus factores asociados se han convertido en problemáticas de creciente interés dentro del ámbito hospitalario, y es importante porque es parte de una carrera de alta demanda académica. En los internos del hospital Boliviano Holandes y hospital Los Pinos, estas condiciones pueden

presentarse debido a las intensas cargas académicas, las prácticas preprofesionales, la presión por el desempeño y la proximidad a la culminación de la carrera. Estas exigencias generan un impacto significativo en la salud física, mental y emocional, así como en el rendimiento académico y la satisfacción personal.

La investigación es conveniente porque permitirá identificar el grado de asociación entre el síndrome de Burnout y sus factores asociados, dos fenómenos que afectan de manera silenciosa a los estudiantes universitarios. A través de este estudio se podrán obtener datos concretos que ayuden a visibilizar la magnitud del problema en esta población, fortaleciendo la comprensión sobre cómo el agotamiento emocional y la falta de descanso reparador influyen en el desempeño académico, la concentración y la motivación. Los resultados podrán servir como base para futuras intervenciones orientadas al bienestar estudiantil y a la promoción de hábitos saludables de descanso y autocuidado.

Este estudio tiene una trascendencia social significativa, ya que aborda un tema directamente vinculado con la salud mental juvenil, un ámbito que ha cobrado gran relevancia en los últimos años. La relación entre el Burnout y sus factores asociados repercute no solo en la vida académica, sino también en la vida familiar, social y profesional de los internos. Comprender esta relación permitirá que las autoridades hospitalarias y los responsables de programas académicos implementen estrategias preventivas y de apoyo psicológico que favorezcan la estabilidad emocional, la productividad académica y la calidad de vida dentro de la comunidad medica. De esta manera, los beneficiarios directos serán los estudiantes de medicina en internado, mientras que los indirectos incluirán a docentes, tutores y futuros pacientes o usuarios de los servicios profesionales de los egresados.

Desde el punto de vista práctico, los resultados de la investigación servirán para diseñar e implementar programas de intervención, tales como talleres de manejo del estrés, charlas sobre higiene del sueño, y estrategias de afrontamiento adaptativo frente a la presión académica. Además, los hallazgos permitirán elaborar protocolos de detección temprana del Burnout y de factores asociados en la población de internos, optimizando el acompañamiento académico y psicológico. Estos aportes

contribuirán al desarrollo de políticas institucionales orientadas a mejorar la salud mental universitaria y a reducir los índices de deserción o bajo rendimiento académico derivados del agotamiento crónico.

En el ámbito teórico, esta investigación busca aportar conocimiento relevante sobre la interacción entre dos variables psicológicas fundamentales: el síndrome de Burnout y los factores asociados a esta. A pesar de que ambos fenómenos han sido estudiados por separado, existen aún vacíos de conocimiento respecto a cómo se relacionan en contextos hospitalarios específicos, como el de las horas de guardia en el sector de salud en Bolivia. Este estudio, por tanto, contribuirá a fortalecer los modelos teóricos sobre el estrés académico y laboral, la autorregulación emocional y el descanso, además de ofrecer evidencia empírica que respalde el diseño de teorías o programas de intervención adaptados al contexto internado local. Asimismo, los resultados podrían apoyar o contrastar teorías psicológicas sobre el agotamiento emocional, tales como el modelo tridimensional de Maslach, y la escala de estrés percibido (PSS 10) que evalúa el nivel de estrés en la vida cotidian, estos nos ayudarán en un futuro a enriquecer la comprensión de los factores psicosociales que influyen en el síndrome de Burnout y el estrés la laboral abriendo nuevas líneas de investigación en salud mental universitaria.

En síntesis, la presente investigación posee conveniencia práctica, relevancia social, valor teórico y utilidad metodológica, al ofrecer un análisis profundo de una problemática actual que afecta directamente el desempeño y la calidad de vida de los estudiantes de medicina en internado rotatorio. Su desarrollo contribuirá no solo a la generación de conocimiento científico, sino también a la creación de entornos académicos más saludables y sostenibles, promoviendo el desarrollo integral de los futuros profesionales de la Universidad Franz Tamayo.

3.OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

- Comparar el Síndrome de Burnout y estrés laboral como factor asociado en internos de medicina del hospital Holandes y hospital Los Pinos I-2026.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar la relación que existe según los niveles de estrés laboral que existe entre los internos de medicina del Hospital Boliviano Holandes y los del Hospital Los Pinos acorde a resultados del cuestionario de estrés percibido (PSS 10).
- Evaluar la correlación entre las horas de guardia y las dimensiones del síndrome de Burnout en los internos de medicina del Hospital Boliviano Holandes y los del Hospital Los Pinos.
- Analizar la relación entre la calidad de sueño y el nivel de síndrome de Burnout por los internos del Hospital Boliviano Holandes y los del Hospital Los Pinos.
- Relacionar las horas de guardia y las dimensiones del síndrome de Burnout internos de medicina del Hospital Boliviano Holandes y los del Hospital Los Pinos.
- Comparar las diferencias de resultados del cuestionario Maslach Burnout Inventory en los internos de medicina del Hospital Boliviano Holandes y los del Hospital Los Pinos.

4. DISEÑO DEL ESTUDIO

4.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN

El enfoque de investigación se refiere a la orientación que va a tomar el investigador para resolver el problema, se divide en 2: enfoque cuantitativo y cualitativo.

Por la presente investigación, se utilizara el enfoque cuantitativo, este, según Hernandez, se define como un conjunto de procesos secuenciales y probatorios, en los cuales cada etapa precede a la anterior, sin saltar ningún paso, de las preguntas se

establecen hipótesis, y de estas se elabora un plan para comprobarlas mediante la medición de variables en un determinado contexto (4).

Se utilizará el enfoque cuantitativo porque planteamos un problema concreto, revisaremos la literatura para establecer un marco teórico, generamos una hipótesis a partir de la pregunta, recolectamos datos fundamentados por la medición, y analizaremos los resultados en base a métodos estadísticos.

4.2. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN

El alcance de la investigación se refiere a la estrategia que seguiremos como investigadores para guiar el proyecto.

En la presente investigación se utilizará el alcance correlacional, este, según Hernandez, se define como, un tipo de estudio que tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular. En ocasiones sólo se analiza la relación entre dos variables o más (4).

Se utilizará este alcance debido a que mediremos el grado de relación que existe entre la variable de factores determinantes de cefalea, la cefalea, y los estudiantes, también conoceremos el comportamiento de las variables para así establecer un resultado concreto.

4.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El diseño de la investigación se refiere a una estrategia concebida para responder a las preguntas de investigación.

En la presente la investigación se utilizara el diseño cuantitativo, transeccional, correlacional-causal, este se define, según Hernandez, como un tipo de investigación en el que se describen variables y se analiza su incidencia e interrelación en un momento dado, como una “fotografía”, específicamente describe la relación entre 2 o más variables, pero no de variables individuales, sino de sus relaciones (4).

Se utilizará este diseño debido a que recolectamos datos y estableceremos su relación, analizaremos los resultados correlacionales y sacaremos una conclusión concreta y causal.

4.4. MÉTODO

El método de la investigación se refiere a una manera o forma de realizar la investigación de manera sistemática, se dividen en métodos teóricos y empíricos.

En la presente investigación se utilizara el método empírico-medición, este se define, como un proceso basado en la recopilación de datos cuantitativos que indican regularidades (4).

Se utilizará este método debido a que recolectamos datos cuantitativos precisos, estableceremos un punto común entre todos, y resaltaremos un resultado que resuma los datos obtenidos.

4.5. TÉCNICA

La técnica de investigación se refiere al procedimiento o manera de obtener datos de manera secuencial, se divide en 4, análisis documental, análisis de contenido, observación, encuesta estructurada y entrevista.

En la presente investigación se utilizará la técnica de encuesta estructurada, esta se define, según Arias, como una técnica que pretende obtener información de un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos o en relación a un tema en particular (5).

Se utilizará esta técnica debido a que guardaremos los datos en un medio material, los datos podrán ser recuperados, y haremos uso de un instrumento propio de la encuesta, el cuestionario.

4.6. INSTRUMENTO

Un instrumento de recolección de datos se refiere a un recurso que el investigador usa para obtener, registrar y almacenar datos.

En la presente la investigación se utilizara el instrumento propio de la técnica de la encuesta, el cuestionario, más específicamente el cuestionario Maslach, para estrés utilizaremos el cuestionario de estrés percibido (PSS) y para la calidad de sueño se tomara en cuenta al cuestionario The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Estas encuestas serán físicas y esta se define según áreas, compuesta por una serie de preguntas, la cual no debe ser intervenida por el encuestador (5).

Se utilizará esta técnica debido a que suministraremos de una serie de preguntas con preguntas cerradas a un grupo de sujetos para obtener datos cuantitativos destinados a la tabulación y al análisis.

4.7. POBLACIÓN

La población, según Roberto Hernández Sampieri, se define como el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones y sobre los cuales se pretende generalizar los resultados de la investigación (4).

En el presente estudio, la población está constituida por los internos de medicina de 25 a 45 años que realizan su internado rotatorio en el Hospital Boliviano Holadés y el Hospital Los Pinos, en la ciudad de La Paz, durante el periodo comprendido entre febrero y junio de la gestión 2026.

Esta población incluye a todos los sujetos que cumplen con las características de interés para la investigación, considerando su participación activa en actividades clínicas y su exposición a factores relacionados con el estrés laboral y el síndrome de Burnout.

Se trabajará con la totalidad de los individuos disponibles en el periodo de estudio, por lo que no se realizará diferenciación entre universo y muestra, acordándose la población en su conjunto, lo que corresponde a un estudio de tipo censal.

5.ASPECTOS ÉTICOS Y DE BIOSEGURIDAD

La investigación contará con la participación de internos de medicina que realizan actividades clínicas, tanto del hospital municipal Los Pinos y hospital Boliviano

Holandes, como equipo de investigación garantizamos el cumplimiento de los principios éticos establecidos para la investigación.

5.1. Aspectos éticos: Este estudio contará y se regirá bajo los principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, esto asegurará que la participación sea beneficiosa tanto para el equipo como para los participantes, evitando causar cualquier tipo de daño psicológico, físico o académico, procurando qué todo el proceso se realice de manera justa y equitativa, asegurando que los datos obtenidos sean utilizados exclusivamente con fines académicos y científicos

5.2. Consentimiento informado: Cada interno o participante de la presente investigación firmará un documento legal en el cual se explicará los riesgos y beneficios, el procedimiento de participación que en este caso son encuestas relacionadas a la investigación, y la confidencialidad de la información proporcionada.

5.3. Confidencialidad: Este es un aspecto importante en la presente investigación, ya que al trabajar con información proporcionada por personas que participan de manera voluntaria es necesario proteger la identidad de tales, por ello la encuesta se realizará de forma anónima y confidencial, esto garantiza el respeto a su dignidad y privacidad evitando cualquier repercusión en el ámbito académico, laboral y personal.

5.4. Reclutamiento de participantes: El reclutamiento se ejecutará por medio de documentos y permisos de dichos hospitales, donde con su autorización se podrá acceder a la lista completa de internos de medicina para así dar paso a la ejecución de encuestas.

5.5. Encuestas y revisión de datos: Las encuestas como son las de Maslach y la Escala de estrés percibido, útiles para medir el síndrome de burnout y el nivel de estrés que una persona percibe en su vida durante el último mes respectivamente, cuentan con un respaldo científico, lo cual es crucial para la evidencia. La revisión de datos y hallazgos serán verificados y almacenados de

forma segura, solo estarán disponibles para los investigadores, utilizándose exclusivamente con fines científicos.

6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

	Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio			
Meses semana de actividades	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Selección de tema de investigación																				
Búsqueda de información																				
Construcción del titulo																				
Planteamiento del Problema																				
Determinación de la pregunta de investigación																				
Presentación Primer Avance																				
Establecimiento de Objetivos																				
Redacción de la justificación																				
Construcción del Marco Teórico																				
Determinación de hipótesis																				
Elaboración del cuadro de variables																				
Realización de la Metodología																				
Presentación del Segundo Avance																				
Diseño de instrumentos																				
Procesamiento de datos																				
Plan para la presentación de la información																				
Elaboración del Cronograma y presupuesto																				
Presentación del Protocolo finalizado																				
Revisión y correcciones																				
Defensa final																				
Presentación Nacional																				

7.EQUIPO

El presente trabajo de investigación “SÍNDROME DE BURNOUT ASOCIADO AL ESTRÉS LABORAL EN INTERNOS DE MEDICINA DE 25 A 45 AÑOS EN LOS HOSPITAL BOLIVIANO HOLANDES Y HOSPITAL LOS PINOS, FEBRERO-JUNIO, 2026”, va a ser desarrollado por un equipo conformado por un docente investigador y nueve estudiantes investigadores, quienes participaran en diferentes etapas del estudio como la revisión bibliográfica, recolección de datos, análisis e interpretación de resultados.

Docente investigador:

Dra. Miriam Doritza Bautista Callisaya

- Supervisar el diseño metodológico del proyecto de investigación.
- Asesorar en la elaboración del marco teórico y las revisiones bibliográficas.
- Supervisión del proceso de recolección y análisis de datos.

Revisión del informe final del proyecto de investigación.

El presente trabajo de investigación “SÍNDROME DE BURNOUT ASOCIADO AL ESTRÉS LABORAL EN INTERNOS DE MEDICINA DE 25 A 45 AÑOS EN LOS HOSPITAL BOLIVIANO HOLANDES Y HOSPITAL LOS PINOS, FEBRERO-JUNIO, 2026” , será desarrollado por un equipo conformado por un docente investigador y nueve estudiantes investigadores, quienes participarán en diferentes etapas del estudio como la revisión bibliográfica, recolección de datos, análisis e interpretación de resultados.

Docente investigador:

Dra. Miriam Doritza Bautista Callisaya

- Supervisar el diseño metodológico del proyecto de investigación.
- Asesorar en la elaboración del marco teórico y las revisiones bibliográficas.

- Supervisión del proceso de recolección y análisis de datos.
- Revisión del informe final del proyecto de investigación.

Estudiantes investigadores:

Mary Cielo Sucapuca Apaza

- Realización de conclusión
- Apoyo en la realización de marco teórico.
- Aplicación de encuestas en hospital Boliviano Holandes y hospital los Pinos.

Jhadde Vanessa Escobedo Estofanero

- Realización de los antecedentes
- Apoyo en la realización de marco teórico
- Aplicación de encuestas en hospital Boliviano Holandes y hospital los Pinos.

Ana Yulissa Ticona Quispe

- Realización de los resultados
- Apoyo en la realización de marco teórico
- Aplicación de encuestas en hospital Boliviano Holandes y hospital los Pinos.

Cinthia Elizabeth Calla Ayma

- Introducción y recolección de evidencia
- Apoyo en la realización de marco teórico
- Aplicación de encuestas en hospital Boliviano Holandes y hospital los Pinos.

Albert Pablo Rodriguez Cordova

- Realización de los antecedentes
- Apoyo en la realización de marco teórico
- Aplicación de encuestas en hospital Boliviano Holandes y hospital los Pinos.

Lucía Nataly Márquez Divapuri

- Realización de método de investigación

- Apoyo en la realización de marco teórico
- Aplicación de encuestas en hospital Boliviano Holandes y hospital los Pinos.

Sheyla Mayly Quispe Castro

- Realización de discusión
- Apoyo en la realización de marco teórico
- Aplicación de encuestas en hospital Boliviano Holandes y hospital los Pinos.

Leidy Nikol Cáceres Ccoarite

- Realizar la justificación
- Apoyo en la realización de marco teórico
- Aplicación de encuestas en hospital Boliviano Holandes y hospital los Pinos.

Rosaura Panca Apaza

- Revisión bibliográfica y organización de referencias.
- Apoyo en la realización de marco teórico
- Aplicación de encuestas en hospital Boliviano Holandes y hospital los Pinos.**Estudiantes investigadores:**
- **Realización de método de investigación**
- Apoyo en la realización de marco teórico
- Aplicación de encuestas en hospital Boliviano Holandes y hospital los Pinos.

8.COLABORADORES

El presente proyecto de investigación contará con la colaboración de diferentes instituciones de salud y del equipo de investigadores responsables del estudio .

Entre estos centros colaboradores conformados por el Hospital Los Pinos y el Hospital Boliviano Horlandes ubicados en la ciudad de de la Paz, Bolivia. Se aplicará cuestionarios dirigidos al personal de internado rotatorio en sus respectivas sedes hospitalarias para obtener la información necesaria para el estudio

Así mismo, con la participación por los estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Privada Franz Tamayo - Facultad de ciencias de la Salud, quienes

participaran en las diferentes etapas del proceso de investigación y el posterior análisis de los datos .

De igual manera, se contará con el apoyo del personal de salud y autoridades de los centros hospitalarios participantes, quienes brindarán las facilidades necesarias para la ejecución del estudio dentro de las instituciones.

9.REQUERIMIENTOS FÍSICOS

Para el desarrollo del presente protocolo de investigación es necesario tener una infraestructura física para un desarrollo eficiente de las actividades lo cual nos permitirá llevar una adecuada recolección, procesamiento y análisis de la información.

El primer lugar que vamos a utilizar son las instalaciones de la Universidad Privada Franz Tamayo, sede La Paz**,** que es el principal espacio académico para el desarrollo de nuestro proyecto tomando a disposición ambientes de estudio, biblioteca para trabajos académicos y el acceso a recursos como research4life que nos facilitan la recolección de información y el análisis de los datos obtenidos durante la investigación. Otros lugares en donde se desarrollará la investigación son el Hospital Boliviano Holandés y el Hospital Los Pinos, instituciones donde los estudiantes que cursan su último año de la carrera de medicina realizan su internado rotatorio. Estas instituciones serán utilizadas como parte del contexto donde se encuentra la población de estudio, permitiendo el acceso a los internos de medicina que participarán voluntariamente en la encuesta. Estos hospitales no pertenecen a la universidad directamente, sin embargo, funcionarán como instituciones colaboradoras externas proporcionando el contexto clínico y académico para la realización del estudio.

También es indispensable el uso de computadoras o laptops los que nos permitirán una adecuada recolección, procesamiento y análisis de la información. como también el uso de la bibliografía los cuales respaldaran el marco teórico de la investigación, garantizando el adecuado desarrollo del estudio.

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS

Los gastos requeridos para realizar el estudio de febrero a junio de 2026 se calculan tomando en cuenta los materiales para el trabajo de campo, la logística para trasladarse entre hospitales y los medios necesarios para recopilar datos a través de encuestas.

Concepto	Cantidad	Costo unitario (Bs.)	Costo total (Bs.)
Material para trabajo de campo	9	15	135
Impresión de encuestas	80	1	80
Fotocopias de consentimiento informado	80	0,40	32
Carpetas para organizar encuestas	15	5	75
Bolígrafos	20	2	40
Resaltadores y material de oficina	9	6	54
Logística			
Pasajes transporte público (visitas a hospitales durante el trabajo de campo)	9	17	153
Refrigerios durante jornadas de aplicación de encuestas	80	10	800
Material administrativo			
Impresión de informe final	3	35	105
Memoria USB para almacenamiento de datos	1	40	40

· TOTAL ESTIMADO 901 Bs.

El presupuesto estimado está orientado principalmente a cubrir los gastos de material impreso para la aplicación de encuestas, transporte para el trabajo de campo en los hospitales participantes y materiales administrativos necesarios para la organización y almacenamiento de la información recolectada durante el periodo de estudio.

10.REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Merchán-Galvis ÁM, Albino-Matiz AY, Bolaños-López JE, Millán N, Arias-Pinzón AA. Síndrome de Burnout y factores asociados en estudiantes de Medicina. Educ Med Super [Internet]. 2018 [citado 2025 Nov 29];32(3): [número de páginas]. Disponible en: http://scielo.sld.cu/pdf/ems/v32n3/a14_1377.pdf
2. Pujol-de Castro A, Valerio-Rao G, Vaquero-Cepeda P, Catalá-López F. Prevalencia del síndrome de burnout en médicos que trabajan en España: revisión sistemática y metaanálisis. Gac Sanit [Internet]. 2024;38(102384):102384. Disponible en:http://dx.doi.org/10.1016/j.gaceta.2024.102384
3. (Salinas Nina, W. A. 2023. Prevalencia y distribución del síndrome de Burnout Student en estudiantes de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés. Revista de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca. Disponible en: https://revistas.usfx.bo/index.php/bs/article/view/1422)
4. Hernández-Sampieri R, Mendoza C. Metodología de la investigación : Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. México: Mcgraw-Hill Education; 2018.
5. Arias FG. El Proyecto de Investigación. Introducción a la Metodología Científica. 5ta. Edición. FIDIAS G. ARIAS ODÓN

Consentimiento Informado para Participar en el Estudio sobre síndrome de Burnout" "Conocer el nivel de síndrome de Burnout en internos del hospital Holandes y Hospital Los Pinos"

Investigador responsable: _____

Tutor(a): _____

Usted es invitado(a) a participar en un estudio académico cuyo propósito es evaluar el

nivel de síndrome de Burnout en internos del hospital Holandes y Hospital Los Pinos.

Su participación es completamente voluntaria. Este estudio está dirigido únicamente a

personas mayores de edad según el estado boliviano.

Se le pedirá responder un cuestionario sobre el nivel de Síndrome de Burnout. La

actividad tendrá una duración aproximada de media hora, en la cual va a ser evaluada

sus conocimientos en este ámbito.

Riesgos: La participación en este estudio no conlleva riesgos físicos ni psicológicos

relevantes.

Beneficios: Al participar, contribuirá al desarrollo académico de su carrera y permitirá

obtener información que ayude a mejorar la formación en Síndrome de Burnout.

Confidencialidad

Toda la información recogida será anónima y confidencial. Sus respuestas son anónimas y solamente se usarán con fines académicos.

La participación en este estudio es libre y voluntaria. Puede decidir no participar o

rechazar ser parte del estudio, antes de firmar y aceptar este documento, sin que esto afecte de ninguna manera su situación académica.

Si tiene preguntas o dudas sobre la investigación, puede comunicarse con:

Investigador responsable: _____

Correo/teléfono: _____

He leído la información anterior. Declaro ser mayor de edad, se me explico el objetivo

del estudio, los procedimientos, los beneficios y acuerdo de confidencialidad.

Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme antes de firmar sin consecuencia alguna.

Acepto participar en este estudio.

Firmas

Nombre del participante: _____

Firma del participante: _____

Fecha: ____ / ____ / _____

Firma del investigador responsable: _____

INSTRUMENTO MASLACH BURNOUT INVENTORY HUMAN SERVICES SURVEY (MBI-HSS)

A cada una de las siguientes frases debe responder expresando la frecuencia con que tiene ese sentimiento, marcando con una equis (X) en la casilla correspondiente y número que considere más adecuado, según la intensidad del sentimiento. La escala de valoración es la siguiente.

		Evaluaciones/preguntas	Nunca.	Alguna vez al año o menos.	Una vez al mes o menos.	Algunas veces al mes.	Una vez a la semana.	Varias veces a la semana.	Diariamente.
			0	1	2	3	4	5	6
1	EE	Debido a mi trabajo me siento emocionalmente cansado.							
2	EE	Al final de la jornada me siento agotado							
3	EE	Me encuentro cansado cuando me levanto por las mañanas y tengo que enfrentarme a otro día de trabajo.							
4	PA	Comprendo fácilmente como se sienten los pacientes y mis compañeros.							
5	D	Creo que trato a algunos pacientes / compañeros como si fueran objetos.							
6	EE	Trabajar con pacientes todos los días es una tensión para mí.							
7	PA	Me enfrento muy bien con los problemas que me presentan mis pacientes.							
8	EE	Me siento "quemado" por el trabajo.							
9	PA	Siento que mediante mi trabajo estoy influyendo positivamente en la vida de otros.							
10	D	Creo que tengo un comportamiento más insensible con la gente desde que hago este trabajo.							
11	D	Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente.							
12	EE	Me encuentro con mucha vitalidad.							
13	EE	Me siento frustrado por mi trabajo.							
14	EE	Siento que estoy haciendo un trabajo demasiado duro.							
15	D	Realmente no me importa lo lo que les ocurrirá a algunos de los pacientes / compañeros.							
16	EE	Trabajar en contacto directo con los pacientes me produce bastante estrés.							
17	PA	Tengo facilidad para crear una atmósfera relajada a mis pacientes.							
18	PA	Me encuentro animado después de trabajar junto con los pacientes / compañeros.							
19	PA	He realizado muchas cosas que merecen la pena en este trabajo.							
20	EE	En el trabajo siento que estoy en el límite de mis posibilidades.							
21	PA	En mi trabajo trato los problemas emocionales con mucha calma.							
22	D	Siento que los pacientes me culpan de algunos de sus problemas.							

Cuestionario de estrés percibido PSS

Las preguntas están en escala y hacen referencia a sus sentimientos y pensamientos durante el último mes. En cada caso, por favor indique con una "X" cómo usted se ha sentido o ha pensado en cada situación

- Nunca
- Casi nunca
- De vez en cuando
- A menudo
- Muy a menudo

	Nunca	Casi nunca	De vez en cuando	A menudo	Muy a menudo
1. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha estado afectado por algo que ha ocurrido inesperadamente?					
2. En el último mes, ¿con qué frecuencia se ha sentido incapaz de controlar las cosas importantes en su vida?					
3. En el último mes, ¿con qué frecuencia se ha sentido nervioso o estresado?					
4. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha manejado con éxito los pequeños problemas irritantes de la vida?					
5. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha sentido que ha afrontado efectivamente los					

cambios importantes que han estado ocurriendo en su vida?					
6. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha estado seguro sobre su capacidad para manejar sus problemas personales?					
7. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha sentido que las cosas le van bien?					
8. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha sentido que no podía afrontar todas las cosas que Nunca pudo hacer					
9. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha podido controlar las dificultades de su vida?					
10. En el último mes, ¿con que frecuencia ha sentido que tenia todo bajo control?					

11. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha estado enfadado porque las cosas que le han ocurrido estaban fuera de su control?					
12. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha pensado sobre las cosas que le quedan por hacer?					
13. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha podido controlar la forma de pasar el tiempo?					
14. En el último mes, ¿con qué frecuencia ha sentido que las dificultades se acumulan tanto que no puede superarlas?					

CUESTIONARIO DE PITTSBURGH

ÍNDICE DE CALIDAD DE SUEÑO DE PITTSBURGH (PSQI)

APELLIDOS Y NOMBRE:_____ N.º HºC:_____

SEXO:_____ ESTADO CIVIL:_____ EDAD:_____ FECHA: _____

INSTRUCCIONES:
Las siguientes preguntas hacen referencia a cómo ha dormido Vd. **normalmente durante el último mes**. Intente ajustarse en sus respuestas de la manera más exacta posible a lo ocurrido durante la **mayor parte** de los días y noches del **último mes.**

¡Muy Importante! CONTESTE A TODAS LAS PREGUNTAS

1. Durante el **último mes**, ¿Cuál ha sido, normalmente, su hora de acostarse?

APUNTE SU HORA HABITUAL DE ACOSTARSE: _____

2. ¿Cuánto tiempo habrá tardado en dormirse, **normalmente**, las noches del **último mes**?

APUNTE EL TIEMPO EN MINUTOS: _____

3. Durante el **último mes**, ¿a qué hora se ha levantado **habitualmente** por la mañana?

APUNTE SU HORA HABITUAL DE LEVANTARSE: _____

4. ¿Cuántas horas calcula que habrá dormido **verdaderamente** cada noche durante el **último mes**? (El tiempo puede ser diferente al que Vd. permanezca en la cama).

APUNTE LAS HORAS QUE CREA HABER DORMIDO: _____

Para cada una de las siguientes preguntas, elija la respuesta que más se ajuste a su caso. Intente contestas a TODAS las preguntas.

5. Durante el **último mes**, cuántas veces ha tenido Vd. problemas para dormir a causa de:

a) No poder conciliar el sueño en la primera media hora:
- Ninguna vez en el último mes _____
- Menos de una vez a la semana _____
- Una o dos veces a la semana _____
- Tres o más veces a la semana _____

b) Despertarse durante la noche o de madrugada:
- Ninguna vez en el último mes _____
- Menos de una vez a la semana _____
- Una o dos veces a la semana _____
- Tres o más veces a la semana _____

c) Tener que levantarse para ir al servicio:
- Ninguna vez en el último mes _____
- Menos de una vez a la semana _____
- Una o dos veces a la semana _____
- Tres o más veces a la semana _____

d) No poder respirar bien:
- Ninguna vez en el último mes _____
- Menos de una vez a la semana _____
- Una o dos veces a la semana _____
- Tres o más veces a la semana _____

e) Toser o roncar ruidosamente:
- Ninguna vez en el último mes _____
- Menos de una vez a la semana _____
- Una o dos veces a la semana _____
- Tres o más veces a la semana _____

f) Sentir frío:
- Ninguna vez en el último mes _____
- Menos de una vez a la semana _____
- Una o dos veces a la semana _____
- Tres o más veces a la semana _____

g) Sentir demasiado calor:
- Ninguna vez en el último mes _____
- Menos de una vez a la semana _____
- Una o dos veces a la semana _____
- Tres o más veces a la semana _____

h) Tener pesadillas o «malos sueños»:
- Ninguna vez en el último mes _____
- Menos de una vez a la semana _____
- Una o dos veces a la semana _____
- Tres o más veces a la semana _____

i) Sufrir dolores:

Ninguna vez en el último mes ____
Menos de una vez a la semana ____
Una o dos veces a la semana ____
Tres o más veces a la semana ____

j) Otras razones (por favor, descríbalas a continuación):

_____
_____
_____

Ninguna vez en el último mes ____
Menos de una vez a la semana ____
Una o dos veces a la semana ____
Tres o más veces a la semana ____

6. Durante el **último mes**, ¿cómo valoraría, en conjunto, la calidad de su sueño?

Bastante buena ____
Buena ____
Mala ____
Bastante mala ____

7. Durante el **último mes,** ¿cuántas veces habrá tomado medicinas (por su cuenta o recetadas por el médico) para dormir?

Ninguna vez en el último mes ____
Menos de una vez a la semana ____
Una o dos veces a la semana ____
Tres o más veces a la semana ____

8. Durante el **último mes**, ¿cuántas veces ha sentido somnolencia mientras conducía, comía, o desarrollaba alguna otra actividad?

Ninguna vez en el último mes ____
Menos de una vez a la semana ____
Una o dos veces a la semana ____
Tres o más veces a la semana ____

9. Durante el **último mes**, ¿ha representado para Vd. mucho problema el «tener ánimos» para realizar alguna de las actividades detalladas en la pregunta anterior?

Ningún problema ____
Sólo un leve problema ____
Un problema ____
Un grave problema ____

10. ¿Duerme Vd. solo o acompañado?

Solo ____
Con alguien en otra habitación ____
En la misma habitación, pero en otra cama ____
En la misma cama ____

POR FAVOR, SÓLO CONTESTE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS EN EL CASO DE QUE DUERMA ACOMPAÑADO.

Si Vd. tiene pareja o compañero de habitación, pregúntele si durante el **último mes** Vd. ha tenido:

a) Ronquidos ruidosos.

Ninguna vez en el último mes ____
Menos de una vez a la semana ____
Una o dos veces a la semana ____
Tres o más veces a la semana ____

b) Grandes pausas entre respiraciones mientras duerme.

Ninguna vez en el último mes ____
Menos de una vez a la semana ____
Una o dos veces a la semana ____
Tres o más veces a la semana ____

c) Sacudidas o espasmos de piernas mientras duerme.

Ninguna vez en el último mes ____
Menos de una vez a la semana ____
Una o dos veces a la semana ____
Tres o más veces a la semana ____

d) Episodios de desorientación o confusión mientras duerme.

Ninguna vez en el último mes ____
Menos de una vez a la semana ____
Una o dos veces a la semana ____
Tres o más veces a la semana ____

e) Otros inconvenientes mientras Vd. duerme (Por favor, descríbalos a continuación):

_____
_____
_____
_____
_____

Ninguna vez en el último mes ____
Menos de una vez a la semana ____
Una o dos veces a la semana ____
Tres o más veces a la semana ____